Kapitel 2: Fehldiagnosen und Doppeldiagnosen bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen

Was genau verstehen wir unter dem Begriff „Fehldiagnosen"? Grob gesagt, liegt eine Fehldiagnose dann vor, wenn eine Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Lern- und Gesundheitsbedürfnissen eines hochbegabten Kindes und der Wahrnehmung dieser Bedürfnisse durch andere besteht. Konkreter ausgedrückt, äußert sich diese Diskrepanz entweder durch (a) eine dem Kind zugewiesene psychische Diagnose und/oder Lernschwäche, wenn seine Verhaltensweisen oder Probleme besser durch seine Hochbegabung erklärt werden könnten, und/oder (b) eine übersehene gesundheitliche Störung und/oder ein übersehenes Lernbedürfnis, was auch als versäumte Diagnose bezeichnet werden kann. Jede dieser beiden Situationen kann verheerende Folgen für ein hochbegabtes Individuum haben, denn das Resultat ist nicht nur eine ungeeignete Behandlung, sondern auch ein Ausbleiben der geeigneten Therapie.

Wie verbreitet sind Fehldiagnosen? Wir können zwar keine genauen Angaben machen, doch sicherlich handelt es sich um ein bedeutsames Problem. Gemäß einer im *Journal of Health Economics* veröffentlichten Studie ist es wahrscheinlich, dass etwa 20 Prozent (oder 900 000 der insgesamt 5 Millionen Kinder mit ADHS) fehldiagnostiziert wurden und stimulierende Medikamente mit verhaltensverändernder Wirkung erhalten, deren Langzeitwirkungen bislang noch nicht bekannt sind.[1] Die Autoren legten eine Stichprobe von fast 12 000 Kindergartenkindern zugrunde und kamen zu dem Schluss, dass eine ADHS-Diagnose abhängig vom Alter des Kindes in Relation zu den anderen Kindern aus seiner Gruppe sei. Auch die Einschätzung des Pädagogen, ob das Kind unaufmerksam sei oder die Gruppe störe, hänge vom relativen Alter des Kindes ab. Selbst wenn Pädagogen keine ADHS-Diagnose stellen können, wird ihre Meinung bei der Entscheidung, ob ein Kind von einer Fachperson beurteilt werden soll, mitberücksichtigt (Sax & Kautz, 2003).

Man stellt sich die berechtigte Frage, ob Fehldiagnosen bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen tatsächlich häufiger sind als in der Allgemeinbevölkerung. Offen gesagt stammt der Großteil unserer Informationen hierzu aus Fallstudien und klinischen Beobachtungen. Wie zuvor bereits angemerkt, handelt es sich dabei um bewährte und anerkannte Forschungsansätze. Vor Kurzem ist es uns außer-

dem gelungen, Daten zu gewinnen, die unsere ursprüngliche Auffassung stützen (Webb, Kuzujanakis, Gallagher & Chou, 2013). Es ist logisch, dass die Merkmale hochbegabter Kinder Anlass zu mehr Fehldiagnosen geben, insbesondere wenn man die mangelnde Schulung von Psychologen, Kinderärzten und anderen therapeutischen und beratenden Fachpersonen zum Thema Hochbegabung mit in Betracht zieht.

Warum erhalten so viele hochbegabte Kinder und Erwachsene so viele Diagnosen?

Dafür gibt es drei Hauptgründe. Erstens haben wir festgestellt, dass in den letzten Jahrzehnten ein Trend zur Überdiagnose aufgekommen ist, sodass bestimmte Eigenheiten schnell das Etikett einer Diagnose verpasst bekommen (Gnaulati, 2013; Schlesinger, 2012); parallel dazu steigt der Druck zur Konformität (Robinson, 2015).[2] Es wird großer Wert auf Sozialisation gelegt, sowohl bei Kindern in der Schule als auch bei Erwachsenen in den meisten beruflichen Situationen. Doch man darf nicht vergessen, dass Eigenheiten keine psychischen Störungen sind. Es lohnt, sich hierzu einige Beispiele vor Augen zu führen: Marcel Proust schrieb den Großteil seiner Romane, während er im Bett lag; Beethoven legte so wenig Wert auf persönliche Sauberkeit, dass seine Freunde ihm – während er schlief – die Kleider wegnehmen mussten, um sie zu waschen; William Faulkner tippte am liebsten mit den Zehen, und Alexander Graham Bell deckte seine Fenster ab, sodass die schädlichen Strahlen des Mondes nicht ins Zimmer fallen konnten.[3]

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl psychischer Diagnosen geradezu explodiert. Im Jahr 1950 enthielt das *Diagnostische und Statistische Manual* (DSM) der American Psychiatric Association 106 Diagnosen. Das DSM-II (1968) listete 182 Diagnosen auf; im DSM-III (1980) waren es 265 und im DSM-IV-TR (2000, deutsche Übersetzung: American Psychiatric Association, 2003) 365 Diagnosen. Das zuletzt erschienene DSM-5 aus dem Jahr 2013 (deutsche Übersetzung: American Psychiatric Association, 2018) beschreibt 539 nervöse oder psychische Störungen. Nach Schätzungen einer Studie erfüllt eines von sieben Kindern in den Vereinigten Staaten die DSM-Kriterien für eine psychische, Verhaltens- oder Entwicklungsstörung.[4] Die Mental Health Task Force der American Academy of Pediatrics (AAP) gab eine Inzidenz von bis zu 20 Prozent für DSM-5-Störungen bei Kindern aus den Vereinigten Staaten an und sagte voraus, dass es bei 37–39 Prozent der Kinder bis zum Alter von 16 Jahren zu einer psychischen Diagnose kommen wird. Nach aktuellen Schätzungen haben etwa 11–20 Prozent der Kinder in den Vereinigten Staaten eine emotionale oder Verhaltensstörung gemäß DSM-5-Definition.[5]

Auch die Zunahme bei der Verordnung psychotroper Medikamente ist erwähnenswert, ebenso der Umstand, dass in den USA 85 Prozent der psychotropen Medikamente von einem Arzt verordnet werden, der kein Psychiater ist. Im Jahr 2010 nahm einer von fünf Erwachsenen in den Vereinigten Staaten ein Psychotropikum ein.[6] Im Zeitraum 2011–2012 nahmen 7,5 Prozent der Kinder Medikamente gegen „emotionale oder Verhaltensprobleme" ein[7]; auch Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter erhalten bereits psychotrope Medikamente, häufig „off label", also außerhalb der Zulassung.[8]

Wir zweifeln daran, dass sich die Menschen so sehr verändert haben. Manche Fachpersonen argumentieren dagegen, sie würden einfach immer besser darin, abnormales Verhalten zu diagnostizieren und zu behandeln. Doch es hat den Anschein, als würden immer mehr Verhaltensweisen als außerhalb der Norm und pathologisch angesehen, und da hochbegabte Kinder und Erwachsene häufig ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigen, gibt schon dies Anlass zur Besorgnis im Hinblick auf eine Überdiagnose.

Zweitens besteht bei Fachpersonen ein Mangel an Wissen über die gängigen Merkmale von Hochbegabten, was dazu führt, dass viele typische Verhaltensweisen fälschlicherweise für eine Störung gehalten werden (oder sogar mehrere). Fachpersonen wie Psychiatern, Psychologen und Kinderärzten sowie Lehrern und Schulpsychologen werden nur wenig Kenntnisse vermittelt, um auf Hochbegabung zurückzuführende Verhaltensweisen von Verhaltensweisen unterscheiden zu können, denen diagnostizierbare Verhaltensstörungen zugrunde liegen (Hartnett, Nelson & Rinn, 2004; Silverman, 1998; Webb, 2014).

In der klinischen Ausbildung und Praxis wird ein weitaus größerer Schwerpunkt auf Individuen gelegt, deren Fähigkeitsniveau zwei oder mehr Standardabweichungen *unter* dem Durchschnitt liegt, als auf Personen, deren Fähigkeiten zwei oder mehr Standardabweichungen *über* dem Durchschnitt angesiedelt sind. In der psychologischen Forschung gab es bislang nur in Einzelfällen und in kleinerem Umfang eine Schwerpunktsetzung auf hochbegabte Kinder und Erwachsene (Hayden, 1985; Horowitz & O'Brien, 1985; Webb, 2014); die Veröffentlichung der National Association for Gifted Children (Neihart, Pfeiffer & Cross, 2015) spricht davon, dass in vielen Bereichen ein hoher weiterer Forschungsbedarf besteht.

Drittens gibt es Störungen, wie etwa existenzielle Depression oder Magersucht, die in der Tat mit höherer Wahrscheinlichkeit bei bestimmten Gruppen hochbegabter Kinder und Erwachsener auftreten. Die Diagnosen dieser Störungen sind demnach korrekt (Neihart, 1999; Piirto, 2004; Webb, 1999, 2001, 2014). Aber wie viele dieser Störungen sind ein Produkt der Interaktion zwischen Temperament und Umfeld? Umfeldbedingte Probleme sollten nicht einfach als „Pathologie unbekannter Ursache" betrachtet werden. Eine Veränderung des Umfelds kann viele Erkran-

kungen effektiv behandeln. Wir sind der Ansicht, dass Fachpersonen eine geeignetere Therapie ermöglichen könnten, wenn sie in ihre Planung mehr Verständnis für das psychische Funktionieren einer Person und gleichzeitig auch für ihr Umfeld einfließen ließen – ganz egal, ob das Umfeld ihr Zuhause, ihre Schule oder ihr Arbeitsplatz ist.

Amend und Beljan (2009) untersuchten die Vorbedingungen von Fehldiagnosen, genauer gesagt, die Bedingungen, die eine Fehldiagnose bei Kindern wahrscheinlicher werden lassen. Dabei identifizierten sie mehrere Faktoren, darunter auch das oben bereits erwähnte Versäumnis, eine Hochbegabung in den Beurteilungsprozess miteinzubeziehen. Den Autoren zufolge stellt das mit Hochbegabung verbundene Stigma ein zusätzliches Handicap für eine korrekte Krankheitsbestimmung und Diagnose dar: Haben die Eltern bereits zuvor negatives Feedback von anderen Eltern, Therapeuten oder Lehrern über die Fähigkeiten ihres Kindes erhalten, so kann es sein, dass sie nur ungern mit einer Fachperson über seine Hochbegabung sprechen. Außerdem merkten die Autoren an, dass häufig Medikamente als diagnostisches Werkzeug zum Einsatz kämen, dass der Einfluss von Krankenversicherungen und Managed-Care-Konzepten auf den diagnostischen Prozess zu einer mangelnden Gründlichkeit bei der Diagnostik beitrügen und dass es wichtig sei, Faktoren wie das Umfeld und die Situation der zu beurteilenden Person zu berücksichtigen. Mit den Fehldiagnosen bei Erwachsenen verhält es sich ähnlich (Fiedler, 2015; Nauta & Ronner, 2013; Webb, 2013).

Doppeldiagnosen

Wir möchten noch auf ein weiteres Problem hinweisen, das Einfluss auf eine korrekte Diagnosestellung haben kann. Hochbegabte Kinder und Erwachsene bleiben von psychischen und physischen Erkrankungen nicht verschont. Tatsächlich gibt es sogar einige Störungen, die bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen häufiger vorkommen. Deshalb diskutieren wir im Folgenden Situationen, in denen sich die Hochbegabung und bestimmte diagnostische Kategorien zu überlagern scheinen. Eine solche Doppeldiagnose – Hochbegabung, die gemeinsam mit einer bestimmten anderen zu diagnostizierenden Erkrankung auftritt – hat Auswirkungen auf diese zweifach außergewöhnlichen Personen, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Lernbedürfnisse und Berufstätigkeit als auch hinsichtlich ihrer Therapieplanung. Diese Individuen weisen gleichzeitig eine außergewöhnliche Fähigkeit und eine Beeinträchtigung auf, was eine einzigartige Kombination ergibt. Vielleicht dominiert ihre außergewöhnliche Fähigkeit und überdeckt ihre Beeinträchtigung, oder ihre Beeinträchtigung dominiert und überdeckt ihre außergewöhnliche Fähigkeit; schließlich

könnten auch beide Merkmale das jeweils andere verschleiern, sodass keines der beiden erkannt oder berücksichtigt wird.[9]

Manche Merkmale hochbegabter Kinder und Erwachsener können ausschlaggebend sein, dass Therapeuten und Pädagogen eine ursächliche Störung übersehen. Damit möchten wir sagen, dass die Merkmale von Hochbegabung in der Tat gelegentlich Verwirrung stiften und eine korrekte Diagnose und Intervention erschweren können. Ein begünstigender Faktor für eine Fehldiagnose besteht gemäß Amend und Beljan (2009) darin, dass eine möglicherweise bestehende zweifache Außergewöhnlichkeit nicht in Betracht gezogen wird. Beispielsweise kann die Intelligenz eines jungen Kindes – in Kombination mit cleverem Raten – eine Lernschwäche über mehrere Jahre verschleiern, weil das Kind den Lehrstoff durch bloßes Zuhören oder Zusehen intellektuell aufnehmen kann. Viele Eltern haben uns davon berichtet, dass ihre Kinder ihre sprachlichen Fertigkeiten eingesetzt haben, um ihnen oder der Therapeutin einzureden, es gäbe kein Problem oder die Eltern seien selbst das Problem. Hochbegabte Kinder sind häufig nicht gut darin, ihre eigenen Defizite zu beschreiben, weil sie keine Schwäche zeigen möchten. Oft verharmlosen sie die vorgebrachten Bedenken oder legen sie positiv aus und verhindern so, dass der Therapeut den wahren Problemen auf die Schliche kommt.

Ebenso verhält es sich, wenn hochbegabte Kinder eine eindeutig diagnostizierte Störung oder Erkrankung wie eine Zerebralparese, Seh- oder Hörstörungen oder eine Lernschwäche haben: Tendenziell konzentrieren sich sowohl Fachpersonen als auch Eltern auf die Beeinträchtigung und vernachlässigen oder übersehen die Fähigkeiten des Kindes.[10] In der Folge kommt es zu einer Fehldiagnose, was wiederum andere Probleme nach sich zieht.

Bei manchen hochbegabten Kindern finden sich mehrere, manchmal sogar im Widerspruch zueinander stehende Diagnosen in ihrer Krankengeschichte. Dies deutet entweder darauf hin, dass es sich um ein schwerwiegendes Problem handelt oder dass sich das Kind nicht so leicht in eine diagnostische Kategorie einordnen lässt. Wenn die Diagnosen eines Kindes nur auf den üblichen Verhaltensweisen von Hochbegabten basieren, kann sich eine ziemlich lange Liste ergeben, wobei sich jede der Diagnosen auf ein paar Verhaltensaspekte des Kindes bezieht, aber keine sein Verhalten vollumfänglich erklärt. Wir haben beispielsweise erlebt, dass hochbegabte Kinder gleichzeitig die Diagnosen Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten, Zwangsstörung, ADHS, bipolare Störung und Asperger erhalten haben. Solche Mehrfachdiagnosen trüben den Blick, wirken stigmatisierend und verstärken die Befürchtung des Kindes, dass etwas bei ihm „nicht richtig" sei. Ganz sicherlich ist bei ihm etwas anders, aber nicht zwangsläufig „nicht richtig". Da hochbegabte Kinder bereits von Natur aus außergewöhnlich sind und gewisse Verhaltensmerkmale häufig dramatisch zur Schau stellen, haben sie in der Tat ein höheres Risiko für Mehrfachdiag-

nosen und werden oft fälschlicherweise verdächtigt, gleich mehrere schwerwiegende Probleme zu haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch als Erwachsene mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die (nur sehr eingeschränkt) vorhandene Forschung zu zweifach außergewöhnlichen Erwachsenen hat ergeben, dass Menschen mit hohem IQ und Aufmerksamkeitsstörungen oftmals außergewöhnliche Kämpfe ausfechten müssen, die der Maximierung ihrer Gaben im Wege stehen (Olenchak, Jacobs, Hussain, Lee & Gaa, 2016). Für Erwachsene, deren ADHS im Kindesalter nicht erkannt wurde, wird das emotionale und intellektuelle Dilemma, das darin besteht, unerkannte aufmerksamkeitsbezogenen Konflikte und das aus ihnen häufig resultierende maladaptive Verhalten auszugleichen, zum persönlichen Quell von Scham und Schuldgefühlen, die zu Underachievement, Ängsten und Depression führen können (Brown, 2005). Ein Verständnis für die intellektuellen, sozialen und emotionalen Merkmale hochbegabter Kinder und Erwachsener wird in all diesen unglücklichen Situationen zweifelsohne zu besseren Ergebnissen führen.

Wir haben schon immer gewusst, dass Elijah hochintelligent und gleichzeitig eine Herausforderung ist. Zum ersten Mal suchte ich Hilfe, als er ein Vorschulkind war. Wir lebten damals in Wisconsin. Bei Elijah wurde erst ADHS diagnostiziert, dann eine Hochbegabung. Unser Therapeut sagte mir, dass er eines der willensstärksten Kinder war, mit denen er je gearbeitet hatte. In der Schule wurden bei ihm IQ- und Leistungstests durchgeführt. Elijahs IQ lag bei 138, und seine guten Leistungen in Lesen und Mathematik brachten ihn in diesen Fächern auf High-School-Niveau. Er erhielt teilweise akzelerierten Unterricht, und insgesamt lief es gut. Ich fragte mich immer, ob da noch mehr im Busch war oder ob Elijah „nur" hochbegabt war.

In dem Sommer, bevor er in die zweite Klasse kam, zogen wir dann nach Rhode Island. Obwohl Elijah dort eine großartige Lehrerin hatte, die früher selbst eine hochbegabte Schülerin gewesen war, bekam er erst akzelerierten Unterricht in Mathematik, als das Schuljahr schon recht weit fortgeschritten war. Eines Tages regte er sich fürchterlich auf, weil er bei einem Test keinen Radiergummi dabeihatte. Er bestand den Test nicht, und die Mathematiklehrerin sagte, dass sie ihn in ihrer Klasse nicht mehr dulden würde. In diesem Jahr brachte ihm dann der Lehrer der zweiten Klasse den Stoff der dritten Klasse bei, und wir waren so schockiert von dem Vorfall, dass wir nicht für unseren Sohn Partei ergriffen. Stattdessen sorgten wir uns immer mehr um einige seiner Verhaltensweisen und ließen eine komplette neuropsychologische Untersuchung durchführen, die eine Asperger-Diagnose ergab. Das war ein harter Brocken – ich komme immer noch nicht richtig klar damit, und das, obwohl ich wusste, dass es Schnittmengen zwischen ADHS, Hochbegabung und der Asperger-Störung gibt.

Es war ein harter Kampf, in der Schule Fördermaßnahmen für unseren Sohn durchzuboxen. Zwischen seinen IQ-Subskalen klafft eine deutliche Lücke; bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und dem Arbeitsgedächtnis ist er viel langsamer. Elijah kann dies jedoch größtenteils ausgleichen; er hat alle Fächer in der Schule bestanden. Aktuell sind wir auf der Suche nach weiterer Unterstützung zur Verbesserung seiner exekutiven Funktionen und lassen ihn nochmals neuropsychologisch untersuchen. Elijah hat einen individuellen Förderplan bekommen, aber offen gesagt heißt das nicht viel mehr, als dass er ein 30-minütiges Sozialkompetenztraining in der Gruppe erhält.

Unsere Schule hat weder ein Förderprogramm für Hochbegabte, noch ist irgendjemand dort der Ansicht, dass unser Sohn eines bräuchte, weil er sein Wissen nicht immer zeigt. In Mathematik wurde er jedoch wieder um eine Klassenstufe akzeleriert, und im Schulbezirk versucht man eine Lösung für den Herbst zu finden, wenn er in der letzten Grundschulklasse ist und trotzdem Mathematikunterricht auf einem höheren Niveau bekommen soll. Es ist nicht so, dass er alles automatisch weiß, aber wenn man ihm etwas zeigt, lernt er wirklich schnell. Man hat es nicht leicht, wenn man als zweifach außergewöhnlicher Schüler die Schule besucht – und erst recht nicht, wenn man die Mutter oder der Vater eines solchen Schülers ist!

Die landesweite SENG-Umfrage

Im Jahr 2011 befragte die Non-Profit-Organisation SENG (Supporting Educational Needs of the Gifted) in einer Internet-Umfrage mehr als 3000 Eltern hochbegabter Kinder in den Vereinigten Staaten zu ihren Erfahrungen mit Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich. Dabei beschränkte sich die Umfrage nicht nur auf Familien mit Kindern, die speziellen Förderunterricht für Hochbegabte erhielten. Die Ergebnisse, die bei mehreren Fachkonferenzen präsentiert[11] und bereits zur Publikation eingereicht wurden, beinhalten die folgenden Kernaspekte.[12] Die Eltern gaben an, dass bei ihrem hochbegabten Kind entweder ADHS in Erwägung gezogen (18,2 %) oder es deshalb behandelt wurde (12,8 %). Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert von 31 Prozent. Dies ist nahezu das Dreifache im Vergleich zu den 11 Prozent, die in Veröffentlichungen zu Kindern im Allgemeinen angegeben werden. Ganze 17 Prozent wurden für Asperger oder Autismus-Spektrum-Störungen in Betracht gezogen oder dagegen behandelt, verglichen mit zwei Prozent der Kinder im Allgemeinen – ein hoher Prozentsatz, selbst wenn man berücksichtigt, dass das Asperger-Syndrom generell hochintelligente Kinder betrifft. Bei 18 Prozent wurde eine sensorische Verarbeitungsstörung diagnostiziert, im Vergleich zu fünf Prozent in der allgemeinen Bevöl-

kerung, und bei 13 Prozent eine Zwangsstörung vermutet oder behandelt, was allgemein nur bei 2,7 Prozent der Kinder der Fall ist.

Andere Diagnosen, bei denen starke Abweichungen ersichtlich waren, sind Angsterkrankungen (35 % der hochbegabten Kinder vs. 25 % der Kinder in der Allgemeinbevölkerung), Allergien (57 % der Hochbegabten vs. 25 % allgemein) und Depression (19 % der Hochbegabten vs. 3–6 % allgemein).

Diese Daten stützen unsere klinische Beobachtung, dass hochbegabte Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit Diagnosen erhalten, die auf psychische oder Verhaltensprobleme hindeuten, als dies bei Kindern im Allgemeinen der Fall ist. Die Ergebnisse der SENG-Umfrage zeigen, dass psychische Diagnosen ein ernsthaftes Problem bei hochbegabten Kindern darstellen. Bei einer jüngeren Untersuchung unter 3715 Mitgliedern des Hochbegabtenvereins Mensa wurden ebenfalls viele dieser Störungen erhoben, und auch hier gaben die Teilnehmer ein signifikant höheres Auftreten im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt an (Karpinski, Kolb, Tetreault & Borowski, 2016). Angehörige der Gesundheitsberufe erhalten so gut wie keine zielgerichtete Ausbildung über die Komplexität von Hochbegabung, was ein Grund dafür ist, dass es zu klinischen Fehldiagnosen kommt. Das Schulsystem in den Vereinigten Staaten erfordert vom Kindergarten bis zur 12. Klasse die Vorlage einer klinischen Diagnose, damit Schülern Unterrichtsanpassungen und individuelle Förderpläne gewährt werden können. Der Druck, der durch diese Regelung auf betroffene Familien ausgeübt wird, kann ebenfalls ein Grund für die höheren Prozentzahlen sein.

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Buch ausgeführt wurde, sind hochbegabte Individuen nicht gegen eine gleichzeitig bestehende Störung immun, und einige dieser Prozentabweichungen können durch das Bestehen einer solchen zweifach außergewöhnlichen Situation erklärt werden. Die geschätzte Prävalenz zweifach außergewöhnlicher Individuen variiert stark und wird mit 2–5 Prozent angegeben – ein Wert, der hauptsächlich auf kleine Fallstudien zurückgeht (Foley-Nicpon, Assouline & Colangelo, 2013). Wie viele zweifach außergewöhnliche Menschen es tatsächlich gibt, ist unbekannt, da sie oftmals nicht als solche erkannt oder fehldiagnostiziert werden (Pfeiffer, 2013). Es bedarf weiterer Forschung, um Fehldiagnosen klar von tatsächlichen Doppeldiagnosen abzugrenzen.

Die Rolle der Fachpersonen in Therapie und Beratung

Die Eltern hochbegabter Vorschulkinder klagen oft über Probleme, die mit Schlafstörungen, Disziplin, Schwierigkeiten mit Geschwistern oder Pee[illegible] und Ungeduld gegenüber sich selbst und anderen, einen[illegible]